

Costruttore di Sedute

Modelli pronti di sedute 45 · 60 · 90 minuti per ogni obiettivo. Apri, scegli, applica. Ogni seduta con timing, esercizi, materiali e adattamenti già decisi al posto tuo.

- La struttura standard in 5 fasi che regge qualunque seduta
- 24 modelli pronti: 12 da 45 min · 8 da 60 min · 4 da 90 min di gruppo
- 5 piani settimanali per 5 profili di paziente diversi
- 4 setup di attrezzatura: domicilio, studio/RSA, gruppo, zero euro

Indice

Sei sezioni. Prima la struttura, poi 24 modelli pronti, poi come metterli in fila lungo la settimana e cosa serve davvero per lavorare.

1 · L'anatomia di una seduta perfetta	03
2 · 12 modelli di seduta da 45 minuti	06
3 · 8 modelli di seduta da 60 minuti	14
4 · 4 modelli di seduta di gruppo 90 minuti	19
5 · Il piano settimanale personalizzato	23
6 · Checklist attrezzatura minima	30
7 · Errori tipici nel costruire sedute	33

L'anatomia di una seduta perfetta

Prima di scegliere gli esercizi, decidi l'architettura. Una seduta che funziona ha sempre le stesse cinque fasi, cambiano solo i minuti e il contenuto del blocco centrale.

Il novanta per cento delle sedute che non funzionano falliscono per la struttura, non per gli esercizi. Se salti il riscaldamento la mobilità del blocco centrale è finta; se salti il defaticamento l'anziano se ne va con la frequenza cardiaca ancora alta e il ricordo dello sforzo, non della calma.

La struttura standard che qui adottiamo è la stessa che troverai riprodotta in tutti i 24 modelli delle prossime sezioni. Impararla a memoria significa poter costruire una seduta da zero in pochi minuti anche senza aprire nessun manuale.

1.1 • Le cinque fasi in dettaglio

FASE	DURATA STANDARD	OBIETTIVO	SEGNALE CHE STAI LAVORANDO BENE
1. Accoglienza + respirazione	5 minuti	Abbassare l'attivazione simpatica, portare l'attenzione al corpo, raccogliere lo stato del giorno (dolore, umore, sonno).	Il paziente parla di sé senza che tu debba tirargli fuori le parole.
2. Riscaldamento articolare	8 - 10 minuti	Preparare le articolazioni maggiori con movimenti a bassa ampiezza e senza carico, aumentare gradualmente la frequenza cardiaca.	Al termine il paziente ha il respiro un filo più profondo ma non è in fatica.
3. Blocco tematico	20 - 40 minuti	È il cuore della seduta: qui vive l'obiettivo del giorno (mobilità, equilibrio, forza, cognitivo, riabilitazione...).	Il paziente arriva a percepire lo sforzo ma non lo teme.
4. Defaticamento + stretching	8 - 10 minuti	Riportare la frequenza cardiaca a valori di riposo, allungare i distretti sollecitati, prevenire indolenzimento.	Il respiro torna calmo, il paziente sente il corpo "morbido".
5. Congedo + diario	5 minuti	Chiudere il rito, registrare fatica percepita e sintomi, dare un compito minimo per il giorno seguente.	Il paziente esce con una frase sua sulla seduta, non con la tua.

1.2 • La regola del "1-3-1"

Per il blocco tematico funziona un principio semplice che qui chiamiamo **1-3-1**: **un** esercizio di ingresso al tema (facile, alto successo), **tre** esercizi di lavoro reale (dove sta la progressione), **un** esercizio di uscita a bassa intensità che smonta il tema senza lasciare tensione. La quasi totalità dei modelli che segue è costruita così.

PERCHÉ FUNZIONA

L'ingresso alza l'autoefficacia (il paziente si convince che "oggi ce la fa"). I tre esercizi centrali sono dove chiedi davvero. L'uscita evita che l'ultima sensazione sia lo sforzo.

COME SBAGLIANO QUASI TUTTI

Mettono l'esercizio più duro alla fine "così finiamo forte". Il paziente memorizza la fatica, non il progresso, e alla seduta successiva arriva più diffidente.

1.3 • Serie e ripetizioni per anziani

Dimentica lo schema classico giovani-adulti (3x15, 4x12). Con l'over 65 la regola realistica per iniziare è più bassa e più corta.

PROFILO	SERIE x RIPETIZIONI	PAUSA FRA SERIE	NOTE
Anziano attivo (base)	2 x 8 – 10	60 - 90 secondi	Terza serie solo se la seconda finisce senza cedimento tecnico.
Anziano fragile	1 - 2 x 6 – 8	90 - 120 secondi	Se compare dispnea, chiudere la serie e passare all'esercizio successivo.
Riabilitazione	2 - 3 x 5 – 8	60 - 120 secondi	Priorità alla qualità del movimento, non al numero.
Isometrici	2 x 8 – 15 secondi	60 secondi	Aumentare la durata prima delle serie.
Equilibrio	2 - 3 x 20 – 30 secondi	30 - 60 secondi	Sempre con appoggio disponibile a portata di mano.

REGOLA DELLO STOP

Interrompi immediatamente qualunque esercizio se il paziente presenta uno di questi segnali: dolore acuto nuovo, vertigine, pallore o sudorazione anomala, dispnea che non recupera in trenta secondi, dolore toracico, confusione improvvisa. Segna l'evento nel diario e comunica al medico curante.

1.4 • Il "budget di fatica" della giornata

Ogni anziano arriva alla seduta con una quota di energia già consumata dal resto della giornata. Prima di iniziare, chiedi tre cose in trenta secondi: **come hai dormito, hai già camminato oggi, hai dolore da uno a dieci?** Se il dormire è <5, se ha già camminato più di trenta minuti, o se il dolore è >5, tara la seduta al ribasso: riduci il blocco tematico del venticinque per cento e allunga il defaticamento.

TRUCCO PRATICO

Tieni sempre in tasca una versione "corta" di ogni seduta che hai programmato, con esercizi ridotti a metà. Nei modelli che seguono, l'ultima riga di ogni scheda si chiama **Adattamento se stanco** e ti dà proprio questa versione ridotta.

12 modelli di seduta da 45 minuti

La durata standard per il lavoro individuale in domicilio, studio o RSA.

Ogni modello segue la struttura in 5 fasi, con blocco tematico da 20 - 22 minuti.

Non trovi qui l'illustrazione dei singoli esercizi. Il vault principale contiene oltre milletrecento esercizi con illustrazioni, controindicazioni e progressione: qui trovi lo scheletro della seduta e i nomi degli esercizi da cui pescare. Tienili aperti in parallelo la prima volta.

Modello 1 • Mobilità generale (base, primo mese)

OBIETTIVO

Ripristinare i range articolari di collo, spalle, anche, ginocchia e caviglie. Prima seduta indicata per chi rientra dopo periodo di ridotta attività o per la prima valutazione operativa.

MATERIALI

Sedia stabile con schienale, tappetino, cuscino, bottiglia d'acqua. Nessun attrezzo specifico.

FASE (MINUTI)	CONTENUTO	DOSAGGIO
Accoglienza (0-5)	Respirazione diaframmatica seduti + tre domande di stato.	10 respiri lenti
Riscaldamento (5-13)	Circonduzioni collo, spalle, polsi, caviglie. Marcia sul posto seduti.	2 x 6 per articolazione
Blocco (13-33)	Ingresso: flessione scapolare seduti. Lavoro: cat-camel modificato seduti / apertura toracica con bastone / hip hinge assistito. Uscita: rotazioni tronco lente.	2 x 8 - 10 per esercizio
Defaticamento (33-42)	Stretching passivo spalle, ischiocrurali seduti, gastrocnemio in piedi con appoggio.	3 x 20 sec per lato
Congedo (42-45)	Registrazione fatica percepita (scala 0-10), compito casa: 10 respiri diaframmatici la sera.	—

ADATTAMENTO SE STANCO

Riduci il blocco a soli tre esercizi (elimina hip hinge assistito) e porta le ripetizioni a 1 x 8. Estendi il defaticamento a dodici minuti con l'aggiunta di rilassamento guidato.

Modello 2 • Equilibrio e prevenzione cadute

OBIETTIVO

Migliorare il controllo posturale statico e dinamico, ridurre il tempo di reazione, allenare le strategie di caviglia e di anca.

MATERIALI

Sedia, muro libero da urti, striscia adesiva sul pavimento per il tandem, cronometro. Sempre con appoggio a portata di braccio.

FASE (MINUTI)	CONTENUTO	DOSAGGIO
Accoglienza (0-5)	Check pressione se disponibile, respirazione, domanda specifica su vertigini recenti.	—
Riscaldamento (5-13)	Mobilizzazione caviglie seduti + marcia sul posto in piedi con appoggio.	2 x 10 marce
Blocco (13-33)	Ingresso: stazione bipodolica occhi aperti. Lavoro: semi-tandem / tandem / stazione monopodolica con appoggio. Uscita: passi laterali lenti con appoggio.	2 x 20 - 30 secondi per posizione
Defaticamento (33-42)	Stretching gastrocnemio, tibiale, glutei seduti.	3 x 20 sec per lato
Congedo (42-45)	Diario cadute (ultimi sette giorni), compito casa: due minuti al giorno di stazione bipodolica mentre lavi i denti.	—

ATTENZIONE

Se il paziente riferisce vertigini nell'ultima settimana, non proporre tandem o monopodolica. Rimani sulla bipodolica occhi chiusi con appoggio, aggiungendo trasferimenti di peso.

ADATTAMENTO SE STANCO

Salta la posizione monopodolica e passa al semi-tandem con doppio appoggio. Riduci le serie a due per posizione.

Modello 3 • Rinforzo arti inferiori

OBIETTIVO

Aumentare la forza di quadricipite, glutei e polpacci per migliorare autonomia in salita/discesa scale, alzarsi dalla sedia, uscire dal letto.

MATERIALI

Sedia solida senza rotelle, scalino basso (o gradino della scala di casa), cavigliere leggere opzionali (0,5 - 1 kg).

FASE (MINUTI)	CONTENUTO	DOSAGGIO
Accoglienza (0-5)	Domanda specifica: quante volte oggi ti sei alzato dalla sedia con difficoltà?	—
Riscaldamento (5-13)	Marcia seduti + estensioni ginocchio seduti + calf raise seduti.	2 x 10

FASE (MINUTI)	CONTENUTO	DOSAGGIO
Blocco (13-33)	Ingresso: sit-to-stand assistito. Lavoro: sit-to-stand libero / step-up scalino basso / bridge glutei da supino. Uscita: calf raise in piedi con appoggio.	2 × 8 - 10 per esercizio
Defaticamento (33-42)	Stretching ischiocrurali, quadricipite in piedi con appoggio, glutei da supino.	3 × 20 sec per lato
Congedo (42-45)	Registrare numero di sit-to-stand consecutivi possibili oggi. Confrontare fra due settimane.	—

ADATTAMENTO SE STANCO

Elimina lo step-up e mantieni sit-to-stand assistito con appoggio delle mani sulle cosce. Bridge da supino a due serie da sei.

Modello 4 · Rinforzo arti superiori

OBIETTIVO

Rinforzare deltoidi, bicipiti, tricipiti ed estensori del polso per attività di vita quotidiana (portare la spesa, aprire barattoli, sollevare oggetti dagli scaffali alti).

MATERIALI

Manubri leggeri 0,5 - 2 kg oppure bottigliette d'acqua da mezzo litro / un litro come alternativa a costo zero.
Elastico a bassa resistenza opzionale.

FASE (MINUTI)	CONTENUTO	DOSAGGIO
Accoglienza (0-5)	Domanda ADL: hai avuto difficoltà a portare qualcosa questa settimana?	—
Riscaldamento (5-13)	Circonduzioni spalle avanti/indietro, flessioni polso seduti, apertura chiusura mani.	2 × 10
Blocco (13-33)	Ingresso: alzata frontale senza carico. Lavoro: alzata laterale con manubri / curl bicipiti seduti / estensione tricipite dietro la testa seduti. Uscita: rowing seduti con elastico o senza.	2 × 8 per esercizio
Defaticamento (33-42)	Stretching pettorali contro il muro, tricipiti dietro la testa, avambracci in flessione ed estensione.	3 × 20 sec per lato
Congedo (42-45)	Auto-test: sollevare una bottiglia da un litro sopra la testa, dieci volte, senza compenso lombare.	—

ADATTAMENTO SE STANCO

Tieni solo tre esercizi (alzata laterale, curl, rowing) e passa a due serie da sei senza carico. Defaticamento allungato con automassaggio spalle.

Modello 5 • Cardio dolce

OBIETTIVO

Migliorare capacità aerobica sub-massimale, tolleranza allo sforzo prolungato, resistenza nelle attività quotidiane (camminare in salita, salire due rampe di scale).

MATERIALI

Sedia, spazio libero di almeno tre metri per la marcia, cronometro. Cyclette da camera opzionale se disponibile.

FASE (MINUTI)	CONTENUTO	DOSAGGIO
Accoglienza (0-5)	Rilevare frequenza cardiaca a riposo se possibile. Domanda: dispnea al mattino?	—
Riscaldamento (5-13)	Marcia sul posto lenta seduti poi in piedi con appoggio, circonduzioni braccia.	Continuativo
Blocco (13-33)	Intervalli marcia veloce sul posto / marcia lenta di recupero, con progressione: 30" veloce / 60" lento, per otto ripetizioni. Fatica percepita target 4-5/10.	8 intervalli
Defaticamento (33-42)	Marcia lenta continua, respirazione lunga, stretching gastrocnemio.	—
Congedo (42-45)	Frequenza cardiaca finale + fatica percepita.	—

SICUREZZA CARDIO

Non superare mai la fatica percepita 6/10 nelle prime quattro settimane. Se il paziente ha patologia cardiaca nota, richiedere sempre parere del medico curante prima di iniziare e ridurre gli intervalli a 20"/90".

ADATTAMENTO SE STANCO

Riduci a quattro intervalli e passa a 20" veloce / 90" lento. Blocco totale otto minuti invece di venti.

Modello 6 • Postura e schiena

OBIETTIVO

Correggere l'atteggiamento cifotico, mobilizzare la colonna dorsale, rinforzare i muscoli scapolari e paraspinali, ridurre il dolore lombare cronico non specifico.

MATERIALI

Sedia, tappetino, cuscino, bastone leggero (o manico di scopa). Elastico opzionale.

FASE (MINUTI)	CONTENUTO	DOSAGGIO
Accoglienza (0-5)	Osservare postura seduta iniziale + scala dolore lombare 0-10.	—
Riscaldamento (5-13)	Basculamenti bacino seduti, cat-camel seduti, apertura toracica con bastone.	2 × 10

FASE (MINUTI)	CONTENUTO	DOSAGGIO
Blocco (13-33)	Ingresso: retrazioni scapolari seduti. Lavoro: rowing con elastico / superman modificato prono / extensioni toraciche con bastone dietro la nuca. Uscita: rotazioni tronco seduti lente.	2 × 8 per esercizio
Defaticamento (33-42)	Stretching pettorali contro spigolo del muro, allungamento lombare in scarico da supino ginocchia al petto.	3 × 20 sec per lato
Congedo (42-45)	Rilevare dolore lombare 0-10 confrontato con inizio. Compito: dieci retrazioni scapolari ogni ora della giornata.	—

ADATTAMENTO SE STANCO

Salta il superman prono e mantieni solo lavoro seduto. Riduci a due serie da sei. Defaticamento a dodici minuti con più tempo allo stretching lombare in scarico.

Modello 7 • Coordinazione fine delle mani

OBIETTIVO

Migliorare destrezza e forza di presa per attività strumentali quotidiane (allacciarsi bottoni, aprire chiusure a vite, scrivere, usare posate). Utile in prevenzione e in fase iniziale di deterioramento cognitivo.

MATERIALI

Palline di spugna, bottoni di diversa misura, mollette da bucato, pinza da cucina, elastico per dita, tappi di bottiglia, contenitore per selezionare oggetti.

FASE (MINUTI)	CONTENUTO	DOSAGGIO
Accoglienza (0-5)	Test rapido di presa (aprire e chiudere pugno) per venti secondi, conta ripetizioni.	—
Riscaldamento (5-13)	Mobilizzazione polsi e dita, apertura chiusura ampia, opposizione pollice.	2 × 10
Blocco (13-33)	Ingresso: strizzare palla di spugna. Lavoro: prendere e spostare bottoni con pinza / pinza con elastico dita / smontare mollette dai bordi di un cartone. Uscita: passare palla piccola da una mano all'altra a occhi chiusi.	2 × 30 - 60 secondi per esercizio
Defaticamento (33-42)	Automassaggio mani con crema, stretching flessori polso, tenersi le mani in acqua tiepida (se disponibile) per 3 minuti.	—
Congedo (42-45)	Ripetere test iniziale, confrontare.	—

ADATTAMENTO SE STANCO

Passa a soli due esercizi (palla di spugna + spostare bottoni) e allunga il defaticamento con crema e acqua tiepida a otto minuti.

Modello 8 • Cognitivo leggero

OBIETTIVO

Combinare attività motoria e stimolazione cognitiva (dual task) per prevenzione del declino cognitivo lieve. Utile in casi di Mild Cognitive Impairment iniziale.

MATERIALI

Sedia, palla morbida, foglio con parole scritte grandi, calendario, orologio da parete.

FASE (MINUTI)	CONTENUTO	DOSAGGIO
Accoglienza (0-5)	Orientamento verbale: che giorno, che mese, che ora circa.	—
Riscaldamento (5-13)	Marcia sul posto seduti mentre conta a voce alta all'indietro da 20.	2 x 20 marce
Blocco (13-33)	Ingresso: passarsi la palla dicendo un nome di frutta. Lavoro: alzarsi dalla sedia dicendo una parola che inizia per lettera assegnata / marcia sul posto elencando parole di una categoria / passarsi palla nominando animali senza ripetere. Uscita: seduti, respirazione lenta contando all'indietro da 30.	2 x 60 - 90 secondi per esercizio
Defaticamento (33-42)	Stretching + racconto libero: due cose fatte oggi, due cose per domani.	—
Congedo (42-45)	Ripetere orientamento iniziale + dare parola-obiettivo per la prossima seduta.	—

ATTENZIONE DUAL TASK

Se il paziente ha equilibrio compromesso, esegui gli esercizi dual task esclusivamente da seduto. La combinazione fra compito cognitivo e stazione in piedi aumenta significativamente il rischio caduta.

ADATTAMENTO SE STANCO

Solo esercizi seduti, un compito per volta (non veri dual task). Ridurre le richieste cognitive a categorie facili (nomi propri, cibi).

Modello 9 • Recupero post-caduta, fase 1

OBIETTIVO

Prima seduta operativa dopo la caduta senza frattura, quando il medico ha dato il via libera. Ricostruire fiducia nel movimento, ridurre i trasferimenti di base.

MATERIALI

Letto o divano stabile, sedia con braccioli, cintura di sicurezza (opzionale ma consigliata), tappetino imbottito.

FASE (MINUTI)	CONTENUTO	DOSAGGIO
Accoglienza (0-5)	Anamnesi della caduta: come, quando, cosa stavi facendo, sei riuscito ad alzarti da solo. Scala paura di cadere 0-10.	—

FASE (MINUTI)	CONTENUTO	DOSAGGIO
Riscaldamento (5-13)	Solo da supino / seduto: mobilizzazione caviglie, ginocchia, anche. Respirazione.	2 x 10
Blocco (13-33)	Ingresso: rotolamento supino → decubito laterale assistito. Lavoro: passaggio decubito laterale → seduto sul bordo del letto assistito / seduto → in piedi con braccioli / trasferimento sedia-letto con appoggio. Uscita: seduto sul bordo con oscillazione gambe.	2 x 4 - 6 ripetizioni per trasferimento
Defaticamento (33-42)	Rilassamento supino, respirazione, automassaggio zone contuse.	—
Congedo (42-45)	Simulare una volta il "cosa faccio se cado a terra da solo": strategia a quattro appoggi per raggiungere una sedia.	—

SICUREZZA POST-CADUTA

Non forzare mai la stazione eretta al primo incontro se il paziente esprime paura. La fase 1 può ripetersi per due o tre sedute prima di passare alla fase 2. La priorità è rifondare la fiducia, non recuperare in fretta.

Modello 10 · Recupero post-caduta, fase 2

OBIETTIVO

Passo successivo alla fase 1: reintrodurre stazione eretta e camminata assistita in sicurezza, esposizione graduata al movimento che il paziente teme.

MATERIALI

Girello o bastone, sedie disposte come stazioni di appoggio, percorso libero da tappeti e ostacoli.

FASE (MINUTI)	CONTENUTO	DOSAGGIO
Accoglienza (0-5)	Scala paura di cadere confrontata con fase 1.	—
Riscaldamento (5-13)	Marcia seduti + estensioni ginocchio + trasferimento di peso da seduto.	2 x 10
Blocco (13-33)	Ingresso: stazione eretta con doppio appoggio 30 secondi. Lavoro: camminata di due passi tra due sedie / camminata assistita con girello per cinque metri / percorso semplice con curva. Uscita: seduta controllata su sedia con braccioli.	2 - 3 ripetizioni per esercizio
Defaticamento (33-42)	Stretching seduti + rilassamento.	—
Congedo (42-45)	Registrazione dei metri percorsi in autonomia oggi. Verifica settimana su settimana.	—

ADATTAMENTO SE STANCO

Salta il percorso con curva. Camminata di due passi tra due sedie, tre volte, con recupero seduto di sessanta secondi fra un tentativo e l'altro.

Modello 11 • Seduta interamente seduta (pazienti allettati o quasi)

OBIETTIVO

Mantenere trofismo muscolare, articularità, tono cardiovascolare e stimolazione cognitiva per pazienti con mobilità molto ridotta o allettati che vengono trasferiti in poltrona.

MATERIALI

Poltrona o sedia con schienale alto, bastone, palla morbida, cavigliere leggere opzionali. Nessun trasferimento richiesto.

FASE (MINUTI)	CONTENUTO	DOSAGGIO
Accoglienza (0-5)	Respirazione diaframmatica, mobilizzazione passiva del collo se necessario.	—
Riscaldamento (5-13)	Circonduzioni tutte le articolazioni disponibili da seduti, marcia seduti con sollevamento coscia.	2 × 8
Blocco (13-33)	Ingresso: alzata frontale braccia senza carico. Lavoro: estensione ginocchio seduti / calf raise seduti / rowing con bastone seduti. Uscita: passarsi la palla da una mano all'altra.	2 × 8 - 10 per esercizio
Defaticamento (33-42)	Stretching da seduti: collo, spalle, ischiocrurali con gamba appoggiata su sgabello.	3 × 20 sec
Congedo (42-45)	Momento di conversazione libera, ricordare che il movimento fatto oggi conta anche se piccolo.	—

Modello 12 • Domicilio senza attrezzi

OBIETTIVO

Seduta completa quando arrivi a casa del paziente e non hai portato materiali. Tutto con oggetti già presenti in una qualsiasi abitazione.

MATERIALI (DI CASA)

Sedia della cucina, due bottiglie d'acqua chiuse, manico di scopa, cuscino del divano, tappeto tolto (rischio caduta), sgabello basso.

FASE (MINUTI)	CONTENUTO	DOSAGGIO
Accoglienza (0-5)	Ispezione rapida dell'ambiente: tappeti scivolosi da spostare, illuminazione sufficiente.	—
Riscaldamento (5-13)	Marcia sul posto in cucina + circonduzioni braccia con manico di scopa.	2 × 10
Blocco (13-33)	Ingresso: sit-to-stand dalla sedia della cucina. Lavoro: alzata laterale con bottiglie d'acqua / step-up con sgabello / rowing con manico di scopa e resistenza dell'operatore. Uscita: apertura toracica con manico di scopa.	2 × 8 - 10 per esercizio
Defaticamento (33-42)	Stretching seduti + rilassamento cuscino sul divano.	—
Congedo (42-45)	Lasciare al paziente due esercizi con oggetti di casa da eseguire nei giorni fra una visita e l'altra.	—

BONUS OPERATIVO

Il Modello 12 è anche la seduta di riserva quando l'attrezzatura promessa non c'è o è rotta. Averlo in testa risparmia la brutta figura di dire "oggi non possiamo lavorare".

8 modelli di seduta da 60 minuti

La durata "comoda" per sedute in studio o RSA quando il tempo lo permette. Rispetto ai modelli da 45 minuti, il blocco tematico sale a 30 - 32 minuti e apre spazio a componente cognitiva o sociale integrata.

Non ripetiamo qui i modelli 3, 4, 7, 11 del capitolo precedente: sono già facilmente espandibili a sessanta minuti raddoppiando le serie del blocco. Quello che segue sono le otto varianti che davvero cambiano volto se hai un quarto d'ora in più.

Modello 60' • Mobilità + cognitivo

FASE (MINUTI)	CONTENUTO
Accoglienza (0-5)	Orientamento verbale + respirazione.
Riscaldamento (5-15)	Mobilizzazione articolare completa seduti e in piedi con appoggio.
Blocco A - mobilità (15-35)	Sequenza mobilità del Modello 1 (base 45'), estesa a 2 x 10.
Blocco B - cognitivo (35-45)	Dual task seduto: apertura toracica con bastone mentre nomina città italiane per lettera.
Defaticamento (45-55)	Stretching esteso + rilassamento guidato.
Congedo (55-60)	Racconto libero della seduta + diario.

Modello 60' • Equilibrio avanzato con percorsi

FASE (MINUTI)	CONTENUTO
Accoglienza (0-5)	Test rapido: stazione monopodolica occhi aperti, tempo massimo tenuto.
Riscaldamento (5-15)	Marcia in piedi con appoggio, trasferimenti di peso, mobilizzazione caviglie.
Blocco A - statico (15-30)	Bipodolica occhi chiusi / semi-tandem / tandem, tutti con appoggio in autonomia.
Blocco B - dinamico (30-45)	Percorso semplice: camminata su striscia + curva + passaggio sopra ostacolo basso + fermata su comando.
Defaticamento (45-55)	Stretching arti inferiori + respirazione seduti.
Congedo (55-60)	Ripetere test iniziale + registrazione differenza.

Modello 60' · Cardio + forza integrati (circuito)

FASE (MINUTI)	CONTENUTO
Accoglienza (0-5)	Frequenza cardiaca a riposo + fatica percepita mattutina.
Riscaldamento (5-15)	Marcia sul posto crescente + mobilizzazione articolare.
Blocco circuito (15-45)	Quattro stazioni: sit-to-stand / marcia sul posto / alzata laterale con bottiglie / calf raise con appoggio. 45" lavoro + 45" recupero. Tre giri completi.
Defaticamento (45-55)	Camminata lenta + stretching completo.
Congedo (55-60)	Frequenza cardiaca finale, tempo di recupero a valori basali.

SICUREZZA CIRCUITO

Il modello a circuito è indicato solo per anziani già valutati come attivi. Non proporre a chi non ha completato almeno quattro settimane di allenamento continuativo o a chi ha patologia cardiaca instabile.

Modello 60' · Post-caduta fase 3 (reintegro autonomia)

FASE (MINUTI)	CONTENUTO
Accoglienza (0-5)	Scala paura di cadere confrontata con fasi 1 e 2.
Riscaldamento (5-15)	Marcia seduti + trasferimento di peso in piedi con appoggio + sit-to-stand assistito.
Blocco A - equilibrio (15-30)	Semi-tandem / stazione monopodolica con appoggio / trasferimenti di peso multidirezionali.
Blocco B - camminata (30-45)	Camminata assistita in percorso semplice, poi in autonomia con osservazione stretta.
Defaticamento (45-55)	Stretching seduti + rilassamento.
Congedo (55-60)	Simulazione: "come rialzarti se cadi", strategia a quattro appoggi.

Modello 60' · Cognitivo strutturato

FASE (MINUTI)	CONTENUTO
Accoglienza (0-5)	Orientamento temporale + racconto di due eventi della giornata.
Riscaldamento (5-15)	Mobilizzazione seduti + esercizio di attenzione (batti le mani a ogni parola che inizia per B).
Blocco A - motorio con dual task (15-30)	Sit-to-stand contando all'indietro / marcia in piedi con appoggio enumerando mesi / passarsi palla nominando parole di una categoria.
Blocco B - cognitivo puro (30-45)	Memoria a breve termine (tre parole ripetute dopo cinque minuti) + fluenza verbale + orologio disegnato su foglio.

FASE (MINUTI)	CONTENUTO
Defaticamento (45-55)	Stretching + rievocazione: ricordi tre parole di prima?
Congedo (55-60)	Parola-obiettivo per la settimana.

Modello 60' • Postura + core

FASE (MINUTI)	CONTENUTO
Accoglienza (0-5)	Osservazione posturale seduti e in piedi + dolore lombare 0-10.
Riscaldamento (5-15)	Basculamenti bacino, cat-camel, respirazione toracica ed addominale.
Blocco A - postura (15-30)	Retrazioni scapolari, rowing con elastico, superman modificato prono, estensioni toraciche con bastone.
Blocco B - core (30-45)	Attivazione trasverso da supino, dead bug modificato, bird dog assistito, ponte glutei.
Defaticamento (45-55)	Stretching lombare in scarico + pettorali.
Congedo (55-60)	Confronto dolore lombare inizio/fine + tre compiti a casa.

Modello 60' • Prevenzione sarcopenia (forza generale progressiva)

FASE (MINUTI)	CONTENUTO
Accoglienza (0-5)	Rilievo peso (settimanale) + forza di presa se disponibile dinamometro.
Riscaldamento (5-15)	Mobilizzazione + attivazione a corpo libero (sit-to-stand, alzata frontale senza carico).
Blocco forza (15-45)	Cinque esercizi principali con progressione settimanale: sit-to-stand / bridge glutei / rowing con elastico / alzata laterale con manubri / step-up con appoggio. 2 - 3 x 8 - 10 con recupero 90 secondi.
Defaticamento (45-55)	Stretching completo dei distretti allenati.
Congedo (55-60)	Registrazione carichi + fatica percepita per pianificazione seduta successiva.

Modello 60' • Sedentari, prima seduta assoluta

FASE (MINUTI)	CONTENUTO
Accoglienza (0-10)	Colloquio esteso: storia di attività passata, aspettative, paure, dolori cronici.
Riscaldamento (10-20)	Solo mobilizzazione articolare seduti, molto lenta, con obiettivo di far scoprire il movimento.
Blocco (20-40)	Ingresso: respirazione + basculamenti. Lavoro: sit-to-stand assistito / alzata frontale senza carico / marcia sul posto. Uscita: apertura toracica.

FASE (MINUTI)	CONTENUTO
Defaticamento (40-52)	Stretching molto delicato + rilassamento guidato.
Congedo (52-60)	Fissare data e ora della prossima seduta + un solo compito facile a casa.
LA REGOLA DEL "PRIMO SÌ" Nella prima seduta assoluta, l'obiettivo non è allenare: è ottenere il "sì, ci vediamo la settimana prossima". Meno esercizi, più conversazione, più successo garantito.	

4 modelli di seduta di gruppo 90 minuti

Il formato tipico per RSA, centri diurni e associazioni. Sei-dodici partecipanti, un animatore, un eventuale co-animatore per gruppi >8. Struttura più lunga perché include gestione dell'ingresso, socialità e livelli misti.

Il gruppo non è la somma di sedute individuali. È un oggetto diverso, dove il ritmo lo detta il partecipante più lento, l'umore lo detta il partecipante più espansivo, e il tuo lavoro è tenere in scena tutti senza escludere nessuno. I quattro modelli qui sotto danno l'ossatura; le variabili le decidi tu ogni volta.

Modello G1 • Gruppo mobilità base

SETUP SALA

Sedie disposte a semicerchio, distanza minima 80 cm fra una sedia e l'altra, animatore al centro visibile a tutti, spazio libero davanti per possibili esercizi in piedi.

RUOLO ANIMATORE

Voce chiara, dimostra ogni esercizio prima di chiederlo, guarda in faccia ogni partecipante almeno una volta per fase, adatta in tempo reale.

FASE (MINUTI)	CONTENUTO
Ingresso e saluto (0-15)	Accoglienza uno a uno, sistemazione sedie, giro di presentazione se gruppo nuovo, respirazione collettiva.
Riscaldamento (15-30)	Circonduzioni tutte le articolazioni seduti, marcia sul posto, seguendo il ritmo di una musica lenta.
Blocco (30-70)	Sequenza mobilità globale con progressione a scelta multipla: chi può, esegue in piedi con appoggio; chi non può, seduto. Ingresso: apertura toracica. Lavoro: sit-to-stand assistito / marcia in piedi con appoggio / alzate braccia con bastone / rotazioni tronco seduti. Uscita: stretching guidato.
Defaticamento (70-80)	Stretching seduti sincronizzato + respirazione.
Congedo (80-90)	Giro rapido: come ti sei sentito oggi, in una parola. Uscita accompagnata.

GESTIONE LIVELLI MISTI

Ogni esercizio ha sempre due versioni annunciate: **versione seduta** (per chi ha equilibrio compromesso) e **versione in piedi con appoggio** (per chi è stabile). Nessuno deve mai sentirsi in colpa se rimane sulla versione base.

Modello G2 · Gruppo equilibrio e prevenzione cadute

SETUP SALA

Sedie in cerchio con un secondo cerchio di sedie di riserva per l'appoggio. Striscia adesiva sul pavimento al centro per esercizi tandem. Nessun tappeto sciolto.

RUOLO CO-ANIMATORE

Necessario per gruppi >6. Sta accanto ai partecipanti con equilibrio più basso e li assiste nelle transizioni seduto-in piedi.

FASE (MINUTI)	CONTENUTO
Ingresso (0-15)	Accoglienza + valutazione visiva di andatura ingresso di ciascuno.
Riscaldamento (15-30)	Marcia sul posto seduti + trasferimenti di peso in piedi con appoggio della sedia.
Blocco A (30-50)	Equilibrio statico: bipodalica, semi-tandem, tandem (chi può). Tutti con appoggio garantito.
Blocco B (50-70)	Equilibrio dinamico: passi laterali con appoggio, camminata su striscia con partner di supporto, cambi di direzione.
Defaticamento (70-80)	Stretching gastrocnemio e ischiocrurali seduti.
Congedo (80-90)	Ricordare la regola d'oro: se stai per cadere, cerca l'appoggio, non evitare la caduta con lo scatto.

REGOLA D'ORO DEL GRUPPO EQUILIBRIO

Nessun partecipante lascia il proprio appoggio senza che almeno un operatore lo veda. Se il rapporto operatori/utenti scende sotto 1:6, cancella la sezione dinamica e resta sul lavoro statico da seduti.

Modello G3 · Gruppo cognitivo + fisico misto

SETUP SALA

Sedie a semicerchio + lavagna o cartellone visibile.
Palla morbida che gira fra i partecipanti. Musica bassa opzionale.

RUOLO ANIMATORE

Alterna guida verbale (compiti cognitivi) e guida motoria. Fa attenzione a chiamare ogni partecipante per nome almeno tre volte durante la seduta.

FASE (MINUTI)	CONTENUTO
Ingresso (0-15)	Orientamento collettivo: giorno, mese, stagione. Racconto libero di due minuti a testa (o a chi vuole).
Riscaldamento (15-30)	Marcia seduti contando alternativamente ad alta e bassa voce.
Blocco A - motorio (30-50)	Sit-to-stand di gruppo con turni + alzata braccia con parola di stagione + passarsi la palla nominando frutta di stagione.
Blocco B - cognitivo (50-70)	Fluenza verbale a squadre / memoria di tre oggetti mostrati / racconto di un ricordo comune (guerra, festa del paese, canzone dell'epoca).
Defaticamento (70-80)	Canto collettivo di canzone italiana conosciuta.

FASE (MINUTI)	CONTENUTO
Congedo (80-90)	Parola-obiettivo per la settimana + saluto.

Modello G4 • Gruppo sociale con musica e ballo

SETUP SALA

Sedie disposte lungo le pareti con spazio libero al centro. Impianto audio, playlist scelta (musica italiana anni '50-'80 secondo profilo del gruppo). Illuminazione calda.

RUOLO ANIMATORE

Modella l'entusiasmo: canta a voce alta, si muove per primo. Estrae la partecipazione dai timidi con inviti diretti e brevi.

FASE (MINUTI)	CONTENUTO
Ingresso (0-15)	Accoglienza + scelta collettiva della prima canzone.
Riscaldamento (15-30)	Mobilizzazione seduti sul ritmo di una canzone lenta.
Blocco A - ballo seduti (30-50)	Coreografia semplice di braccia e testa su musica di media velocità. Chi vuole, si alza in piedi accanto alla sedia.
Blocco B - ballo in piedi (50-70)	Passi laterali, giro su se stessi tenendo la sedia, valzer semplice a due (o a solo con sedia come "partner"). Sempre appoggio garantito.
Defaticamento (70-80)	Canzone lenta finale + respirazione.
Congedo (80-90)	Foto di gruppo (se autorizzata) + saluto e uscita accompagnata.

PERCHÉ IL BALLO FUNZIONA

Il gruppo sociale con musica raggiunge intensità motorie che il paziente rifiuterebbe se le chiamassi "esercizio". Con la musica giusta, la stessa persona che si rifiuta di fare sit-to-stand ne fa venti in dieci minuti ballando. È allenamento vero, mascherato da festa.

Il piano settimanale personalizzato

La seduta singola conta poco. Quello che sposta l'ago è come le sedute si susseguono lungo la settimana e i mesi. Qui trovi cinque template di settimana tipo per cinque profili di paziente.

Il principio di fondo è sempre lo stesso: alternare stimoli, distribuire il carico, lasciare almeno un giorno di recupero fra due sedute di forza sullo stesso distretto, e includere sempre una componente di mobilità quotidiana (anche di soli dieci minuti).

5.1 • Profilo 1 • Anziano attivo autosufficiente

Persona 65-80 anni, indipendente in ADL/IADL, cammina all'esterno regolarmente, nessuna patologia cronica invalidante. Obiettivo: mantenimento e prevenzione sarcopenia.

GIORNO	CONTENUTO	DURATA
Lunedì	Modello 60' · Prevenzione sarcopenia (forza)	60'
Martedì	Camminata all'esterno (autonoma)	30 - 40'
Mercoledì	Modello 45' · Equilibrio prevenzione cadute	45'
Giovedì	Riposo attivo: stretching + respirazione	15 - 20'
Venerdì	Modello 60' · Cardio + forza integrati (circuiti)	60'
Sabato	Camminata all'esterno o attività ricreativa (gruppo ballo, giardinaggio)	45 - 60'
Domenica	Riposo totale	—

PROGRESSIONE MENSILE

Ogni quattro settimane aumenta di una serie il blocco forza del lunedì e prolunga di cinque minuti la camminata del sabato. Rivaluta ogni tre mesi con test funzionali (30 secondi sit-to-stand, TUG).

5.2 • Profilo 2 • Anziano fragile con storia di cadute

Persona 75-90 anni, autonomia parziale, una o più cadute negli ultimi dodici mesi, paura di cadere, ridotta velocità di cammino. Obiettivo: riduzione rischio caduta, recupero fiducia.

GIORNO	CONTENUTO	DURATA
Lunedì	Modello 45' · Equilibrio prevenzione cadute	45'

GIORNO	CONTENUTO	DURATA
Martedì	Compiti a casa: 10 sit-to-stand mattina + 10 sera; 3 × bipodalica occhi chiusi 30 secondi	10 - 15'
Mercoledì	Modello 45' · Rinforzo arti inferiori	45'
Giovedì	Compiti a casa: mobilità caviglie + respirazione	10'
Venerdì	Modello 45' · Mobilità generale + inserto equilibrio	45'
Sabato	Camminata interna casa con familiare accanto	15 - 20'
Domenica	Riposo	—

SEGNALI DI RIESAME

Se il paziente riferisce una nuova caduta, un nuovo dolore persistente da >3 giorni, o un aumento della paura di cadere: sospendi il piano corrente e torna al Modello 45' · Post-caduta fase 1 finché non ripristini fiducia e sicurezza.

5.3 · Profilo 3 · Post-frattura, fase riabilitativa

Persona che ha subito frattura dell'anca, del femore o del polso negli ultimi tre mesi, dimessa dall'ospedale con indicazione riabilitativa. Obiettivo: recupero graduale funzione + prevenzione recidiva.

SETTIMANA / GIORNO	CONTENUTO	DURATA
Settimane 1-2 · Fase acuta		
Lun / Mer / Ven	Modello 45' · Post-caduta fase 1	45'
Mar / Gio	Compiti passivi/isometrici a casa (indicazione medica)	10 - 15'
Settimane 3-6 · Fase sub-acuta		
Lun / Mer / Ven	Alternare Modello 45' · Post-caduta fase 2 e Modello 60' · Post-caduta fase 3	45 - 60'
Mar / Gio / Sab	Compiti a casa: sit-to-stand assistito 2 × 8, mobilizzazione articolazione operata	15 - 20'
Settimane 7-12 · Fase di consolidamento		
Lun / Mer / Ven	Alternare Modello 45' · Rinforzo arti inferiori e Modello 45' · Equilibrio	45'
Sab	Camminata assistita all'esterno se possibile	15 - 30'

ATTENZIONE AL CARICO

Rispetta sempre le indicazioni di carico date dal chirurgo (astensione da carico, carico sfiorante, carico progressivo, carico libero). Nessuna progressione autonoma senza consulto con il curante o l'ortopedico.

5.4 · Profilo 4 · Deterioramento cognitivo iniziale

Persona con Mild Cognitive Impairment o demenza in fase lieve, capacità funzionali ancora conservate ma con progressiva difficoltà a mantenere routine. Obiettivo: rallentare declino, mantenere autonomia, ridurre isolamento.

GIORNO	CONTENUTO	DURATA
Lunedì	Modello 60' · Cognitivo strutturato	60'
Martedì	Modello 45' · Cognitivo leggero (dual task moderato)	45'
Mercoledì	Compiti a casa: camminata con familiare + gioco memoria semplice	30'
Giovedì	Modello 45' · Mobilità generale con inserto cognitivo	45'
Venerdì	Gruppo G4 · Sociale con musica (se disponibile centro diurno)	90'
Sabato	Compiti a casa: fluenza verbale con familiare, canzoni conosciute	15 - 20'
Domenica	Riposo con routine familiare invariata (importante)	—

REGOLA DELLA ROUTINE

Nel deterioramento cognitivo la costanza del giorno e dell'orario conta più della difficoltà dell'esercizio. Meglio una seduta più semplice ma sempre al martedì alle 10 che una seduta perfetta in orari variabili.

5.5 · Profilo 5 · Allettato o mobilità molto ridotta

Persona con mobilità gravemente compromessa, non in grado di trasferirsi autonomamente, spesso costretta a letto o poltrona per gran parte della giornata. Obiettivo: mantenere articolarietà, prevenire complicanze da immobilità (contratture, decubiti, atrofia), stimolare presenza cognitiva.

GIORNO	CONTENUTO	DURATA
Lunedì	Modello 45' · Seduta interamente seduta (in poltrona)	45'
Martedì	Mobilizzazione passiva a letto + cambio postura	20 - 30'
Mercoledì	Modello 45' · Seduta interamente seduta (in poltrona)	45'
Giovedì	Mobilizzazione passiva a letto + massaggio drenante gambe	20 - 30'
Venerdì	Modello 45' · Seduta interamente seduta + stimolazione cognitiva	45'
Sabato	Trasferimento in poltrona per 1 - 2 ore + conversazione	60 - 120'
Domenica	Riposo con cura posturale a carico del caregiver	—

PREVENZIONE LESIONI DA PRESSIONE

Anche nei giorni "di riposo" il caregiver deve garantire cambio di postura ogni due ore, ispezione della cute (talloni, sacro, gomiti, scapole) e idratazione. Segnalare al medico eventuali arrossamenti persistenti che non scompaiono entro trenta minuti dal cambio postura.

5.6 · Regole generali per costruire un piano

ALTERNARE SEMPRE

Non due giorni consecutivi di forza sullo stesso distretto. Non due giorni consecutivi ad alta intensità cognitiva. Mobilità e respirazione possono essere quotidiane.

RIPOSO ATTIVO, NON PASSIVO

I giorni "di riposo" non sono giorni fermi: sono giorni di sola mobilizzazione, stretching, respirazione. Il corpo dell'anziano perde velocemente se sta immobile.

SABATO VARIABILE

Se il piano è duro nei giorni feriali, il sabato è alleggerito. Se il paziente ha vita sociale attiva nel weekend, il sabato può diventare il giorno di riposo vero e il carico si sposta al mercoledì.

RIVALUTAZIONE OGNI 4 SETTIMANE

Ogni mese fermati e chiedi: gli obiettivi sono ancora quelli? La progressione ha avuto senso? Il paziente si diverte? Se una delle tre risposte è "no", cambia qualcosa.

Checklist attrezzatura minima

Quattro setup per quattro contesti diversi. Dal domicilio con dieci pezzi essenziali al gruppo per dieci utenti. Alla fine, il setup zero-euro per chi arriva senza niente.

La regola d'oro: meglio dieci attrezzi che sai usare bene di venticinque che stanno in un armadio. Ogni setup qui è pensato per essere trasportabile in una borsa (domicilio), sistemato in uno studio (RSA), o mobilitato per un gruppo. Nessuna marca specifica: cerca in negozi di articoli sanitari, sportivi, o online generalisti italiani.

Setup 1 • Domicilio (10 pezzi essenziali)

1.	Tappetino arrotolabile antiscivolo	indispensabile
2.	Elastico therabend leggero (rosso/giallo)	lavoro forza soft
3.	Elastico therabend medio (verde/blu)	progressione
4.	Cavigliere leggere 0,5 e 1 kg (una coppia ciascuna)	arti inferiori
5.	Manubri leggeri 1 e 2 kg (una coppia ciascuna)	arti superiori
6.	Bastone di legno o alluminio 1 metro	mobilità toracica
7.	Palla morbida diametro 15-20 cm	coordinazione
8.	Cronometro (o telefono)	controllo tempi
9.	Cintura di sicurezza per trasferimenti	sicurezza
10.	Blocco appunti + scheda paziente	diario di seduta
Totale		10 pezzi essenziali

DOVE COMPRARE IN ITALIA

Sanitarie e ortopedie di zona, catene generaliste di articoli sportivi, marketplace online generalisti. Per le fasce elastiche, considera una scorta di ricambio: si degradano dopo alcuni mesi di uso continuativo.

Setup 2 • Studio o RSA (25 pezzi)

1.		Tutti i 10 pezzi del Setup 1
2.	Set completo elastici therabend (5 resistenze)	progressione
3.	Set completo cavigliere 0,5 - 1 - 2 - 3 kg	range di carico
4.	Set manubri fino a 4 kg	arti superiori
5.	Cuscino propriocettivo (disco morbido)	equilibrio avanzato
6.	Scalino di allenamento regolabile (10-20 cm)	step-up sicuri
7.	Girello / deambulatore per pratica	simulazione ausili
8.	Bastone canadese per pratica	simulazione ausili
9.	Palline di spugna di varie dimensioni	coordinazione mani
10.	Set di bottoni, mollette, tappi	destrezza fine
11.	Coni segnaletici (6 pezzi)	percorsi
12.	Striscia adesiva colorata	tandem, percorsi
13.	Dinamometro per forza di presa	valutazione oggettiva
14.	Sfigmomanometro digitale	controllo pressione
15.	Cronometro digitale grande	visibile al paziente
Totale		25 pezzi per studio completo

Setup 3 • Gruppo (15 pezzi × 10 utenti)

1.	10 sedie stabili con schienale (senza rotelle)	base
2.	10 tappetini arrotolabili	uno per utente
3.	10 bastoni leggeri	uno per utente
4.	10 palle morbide	una per utente
5.	10 elastici leggeri	uno per utente
6.	20 cavigliere leggere (una coppia per utente)	rotazione tra utenti
7.	5 cuscini propriocettivi	rotazione a stazioni
8.	4 coni segnaletici + strisce adesive	percorsi
9.	Impianto audio portatile	musica gruppo sociale
10.	Playlist selezionate per profilo generazione	coinvolgimento
11.	Cartellone lavagna	compiti cognitivi
12.	Pennarelli colorati	attività cartellone
13.	Schede presenza + diario di gruppo	tracciamento
14.	Kit primo soccorso base	obbligatorio
15.	Ausili per emergenza (sedia da trasporto)	sicurezza
Totale		15 categorie per 10 utenti

RAPPORTO OPERATORI / UTENTI

Per gruppi >6 utenti serve sempre almeno un co-animatore. Sotto il rapporto 1:8 evita esercizi in stazione eretta senza appoggio. Con presenza di pazienti fragili, portare il rapporto a 1:4.

Setup 4 • Zero-euro (con oggetti di casa)

1.	Sedia della cucina (stabile, senza rotelle)	base seduta e appoggio
2.	Due bottiglie di plastica riempite d'acqua	manubri improvvisati
3.	Sacchetto di riso o pasta da 500 g	pesetto per polsi
4.	Manico di scopa o mattarello	bastone di mobilità
5.	Cuscino del divano	propriocettività soft
6.	Asciugamano piccolo arrotolato	presa, coordinazione
7.	Sgabello basso della cucina	step-up di casa
8.	Palla di gomma per bambini (se in casa)	coordinazione
9.	Mollette da bucato	destrezza fine
10.	Barattolo di plastica con tappo a vite	rotazione polso
Totale		10 pezzi già in casa

QUANDO IL ZERO-EURO È LA SCELTA GIUSTA

Il setup zero-euro non è solo un ripiego. È la scelta migliore quando il paziente rifiuta l'idea di "acquistare attrezzi", quando lavori con famiglie in difficoltà economica, o quando vuoi che il paziente continui a fare esercizio nei giorni fra una tua visita e l'altra. Se sa che gli servono attrezzi speciali, non si allenerà mai da solo; se sa che gli bastano una sedia e due bottiglie, forse sì.

Errori tipici nel costruire sedute

Otto errori che vediamo ripetersi in ogni contesto professionale, dal domicilio alla RSA. Riconoscerli è metà del lavoro per non commetterli.

Nessuno di questi errori è dovuto a incompetenza. Sono errori di distrazione, di fretta, di ottimizzazione mal riposta. Ogni operatore che lavora sul serio con l'anziano li ha commessi tutti almeno una volta. L'obiettivo è farli tornare in mente al momento giusto, cioè prima della prossima seduta.

ERRORE 1 · LA SEDUTA TROPPO DENSA

Hai fatto un piano con sette esercizi diversi nel blocco tematico. Il paziente ne ha ricordato zero e ne ha eseguiti bene tre. Regola: mai più di cinque esercizi diversi nel blocco tematico di una seduta da 45 minuti. Meglio pochi esercizi eseguiti bene che molti eseguiti male.

ERRORE 2 · SALTARE IL DEFATICAMENTO "PERCHÉ SIAMO IN RITARDO"

La seduta è iniziata con 15 minuti di ritardo perché il paziente aveva bisogno di parlare. Per recuperare, salti il defaticamento. Risultato: il paziente esce con la pressione alterata, l'ultima sensazione è la fatica, e alla prossima seduta arriva più diffidente. Se il tempo è poco, comprimi il blocco tematico. Il defaticamento è sacro.

ERRORE 3 · GLI STESSI ESERCIZI PER TUTTI

Hai trovato una "seduta che funziona" e la ripeti identica per ogni paziente. Ma l'anziano attivo di 68 anni e la persona fragile di 89 non possono seguire lo stesso schema. Ogni paziente merita un piano tarato sul suo profilo (vedi Sezione 5). L'unico modello che si può proporre uguale a tutti è il Modello 45' · Mobilità generale del primo mese.

ERRORE 4 · IGNORARE L'UMORE E LO STATO DEL GIORNO

Il paziente arriva stanco, ha dormito male, ha un dolore nuovo. Tu esegui la seduta pianificata la settimana precedente senza cambiare nulla. Fine seduta: il paziente ne è uscito peggio di come è entrato. Le tre domande di accoglienza (sonno, dolore, attività della giornata) non sono un rito: sono il termometro che orienta l'intera seduta.

ERRORE 5 · SALTARE IL RISCALDAMENTO PERCHÉ "C'È POCO TEMPO"

Simmetrico all'errore 2, ma inverso. Se salti il riscaldamento, il blocco tematico è a rischio infortunio per i primi cinque-otto minuti. Se il tempo manca, comprimi il blocco, non il riscaldamento. La regola è: riscaldamento sempre, in ogni seduta, anche di solo cinque minuti.

ERRORE 6 · PROGRESSIONE TROPPO RAPIDA O TROPPO LENTA

Se aumenti carichi e ripetizioni ogni settimana, il paziente non consolida. Se non li aumenti mai per "non stancarlo", non c'è adattamento. La regola operativa: rivaluta la progressione ogni quattro settimane, non prima e non dopo. Se in quattro settimane il paziente ha eseguito comodamente 2×10 senza fatica, allora è il momento di passare a 3×10 o aumentare il carico.

ERRORE 7 · TRASCURARE IL DIARIO DI SEDUTA

Alla fine di ogni seduta il paziente esce, tu vai al prossimo appuntamento, e non annoti niente. Fra due settimane non ricordi più come è andata, quale carico ha usato, cosa ha detto. Il diario di seduta è breve (tre righe bastano) ma è ciò che ti permette di costruire una progressione reale nel tempo. Senza diario, ogni seduta è la prima.

ERRORE 8 · DIMENTICARE CHE L'ANZIANO NON È UN ADULTO IN MINIATURA

Molti protocolli di allenamento e riabilitazione sono nati per adulti sportivi o giovani post-infortunio. Applicarli tali e quali all'over 75 significa richiedere volumi, intensità e velocità di recupero irreali. Le serie e ripetizioni della Sezione 1, i tempi di pausa più lunghi, il "budget di fatica" della giornata: non sono opinioni, sono la traduzione del fatto che dopo i settanta il corpo lavora in modo diverso.

7.9 · Auto-verifica prima della prossima seduta

Sette domande da farsi in trenta secondi appena prima di iniziare la prossima seduta.

Ho un piano scritto?

Conosco lo stato di oggi?

Ho la versione ridotta pronta?

Il riscaldamento c'è?

Il defaticamento c'è?

Il materiale è pronto?

Il diario è aperto?

LA REGOLA DEI 30 SECONDI

Se una qualsiasi delle sette risposte è "no", trenta secondi in più prima di iniziare valgono molto più di trenta minuti recuperati alla fine. La seduta preparata è la seduta che funziona.

Ora torna al vault

Hai la struttura, i modelli, i piani e la checklist. Adesso ti servono gli esercizi. Il vault principale contiene oltre milletrecento esercizi illustrati con controindicazioni, progressioni e adattamenti: pescali per riempire i blocchi tematici dei modelli che hai visto qui.

Il flusso di lavoro consigliato

1. Scegli il modello di seduta più adatto al paziente di oggi
2. Vai al vault e scegli gli esercizi specifici per il blocco tematico
3. Adatta serie e ripetizioni al profilo del paziente
4. Esegui, registra sul diario, rivaluta ogni quattro settimane